

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE SATISFACCIÓN CON LA VIDA (SWLS)

Eje IV: Bienestar Subjetivo y Recursos Personales • Estándar Oro del Componente Cognitivo de Diener

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS).
Nombre Original	Satisfaction With Life Scale (SWLS; Diener et al., 1985).
Autores Originales	Ed Diener, Ph.D., Robert A. Emmons, Randy J. Larsen y Sharon Griffin (Univ. Illinois).
Adaptación Hispana	Atienza, Pons, Balaguer & García-Merita (2000, 2003); Cabañero et al. (2004); Vázquez et al. (2013).
Eje Clínico y Constructo	Eje IV: Bienestar Subjetivo. Valoración cognitiva global sobre la propia existencia.
Tipo de Instrumento	Cuestionario de autoinforme unidimensional breve (5 reactivos).
Formato de Respuesta	Escala Likert graduada de 7 niveles (1 = Muy en desacuerdo a 7 = Muy de acuerdo).
Población y Rango	Población general de adolescentes y adultos (≥ 12 años) y muestras clínicas.
Tiempo de Administración	1 a 2 minutos de rápida autoadministración.
Régimen de Licencia	Dominio público abierto para investigación académica y práctica asistencial sin royalties.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL JUICIO COGNITIVO GLOBAL DE LA VIDA

La **SWLS** fue diseñada por Ed Diener y colaboradores (1985) en el marco de la psicología del **bienestar subjetivo (SWB)** para subsanar un error teórico frecuente:

- Independencia del Afecto Inmediato:** El bienestar subjetivo se compone de dos facetas: una afectiva (balance emocional entre afecto positivo y negativo, fluctuante ante sucesos cotidianos) y una cognitiva (el juicio evaluativo reflexivo sobre la adecuación de la propia trayectoria vital con respecto a los estándares internos del sujeto).
- Criterios Autógenos del Sujeto:** La escala no impone dominios específicos predefinidos (salud, dinero, pareja); permite que el propio individuo pondere las áreas vitales según sus propios valores personales prioritarios.
- Estabilidad Longitudinal:** A diferencia del estado de ánimo reactivo, la satisfacción con la vida muestra alta estabilidad en el tiempo, constituyendo un rasgo evaluativo de resiliencia psicológica.

3. COMPOSICIÓN DE REACTIVOS Y CLAVE DE RESPUESTA (5 ÍTEMS LIKERT)

Ítem	Enunciado del Reactivo en Español	Dirección	Escala de Calificación (1 a 7)
Ítem 1	En la mayoría de los sentidos, mi vida está cerca de mi ideal.	Directa	1 = Totalmente en desacuerdo
Ítem 2	Las condiciones de mi vida son excelentes.	Directa	2 = En desacuerdo
Ítem 3	Estoy satisfecho/a con mi vida.	Directa	3 = Ligeramente en desacuerdo
Ítem 4	Hasta ahora, he conseguido las cosas importantes que quiero en la vida.	Directa	4 = Neutral / Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Ítem 5	Si pudiera vivir mi vida de nuevo, no cambiaría casi nada.	Directa	5 = Ligeramente de acuerdo 6 = De acuerdo; 7 = Totalmente de acuerdo

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO PSICOMÉTRICO EN ESPAÑA / LATAM

Las adaptaciones y validaciones psicométricas españolas (Atienza et al., 2000, 2003; Vázquez et al., 2013; $N > 1.200$) avalan propiedades métricas óptimas:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Consistencia Interna	Alfa de Cronbach = 0.87 - 0.89	Excelente fiabilidad unifactorial en población adulta y adolescente.
Estabilidad Test-Retest	CCI = 0.84 - 0.88	Alta estabilidad temporal a 1 mes; $r = 0.64$ en seguimiento a 1 año.
Estructura Factorial	CFI = 0.99; RMSEA = 0.03	Confirmación incontestable de estructura estrictamente unidimensional.
Validez Convergente Negativa	$r = -0.62$ (BDI-II)	Correlación inversa robusta con escalas de sintomatología depresiva.
Validez Convergente Positiva	$r = 0.58$ (PANAS Positivo)	Asociación directa coherente con afecto positivo y optimismo de Scheier (LOT-R).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁMPUTO DE PUNTUACIONES

• **Ausencia de Ítems Invertidos:** Los 5 reactivos están redactados en sentido positivo directo. • **Escala de Respuesta:** Calificación de 1 a 7 puntos según el grado de conformidad del sujeto. • **Cálculo de la Puntuación Total Directa (PD):** Suma simple de los 5 reactivos:

$$\text{Puntuación Total SWLS} = \sum_{i=1}^5 \text{Ítem}_i \quad (\text{Rango: 5 a 35 puntos})$$

• **Puntuación Media por Ítem:** Opcionalmente expresada como media normativa (rango 1.0 a 7.0 puntos):

$$\text{Media SWLS} = \frac{\text{Puntuación Total SWLS}}{5}$$

• **Direccionalidad:** A mayor puntuación, mayor satisfacción vital global percibida.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN VITAL

Estratificación	Rango Total	Media Ítem	Significación Clínica y Estado de Bienestar (Pavot & Diener)
Muy Alta Satisfacción	31 a 35 pts	6.2 a 7.0	Vida cercana al ideal; entusiasmo existencial y autorrealización plena.
Alta Satisfacción	26 a 30 pts	5.2 a 6.0	Satisfacción sólida; funcionamiento favorable en la mayoría de áreas vitales.
Promedio / Normativo	21 a 25 pts	4.2 a 5.0	Nivel medio de la población general sana española (media = 23.5 pts).
Punto Neutral	20 pts	4.0	Equilibrio exacto; ni satisfacción ni insatisfacción manifiesta.
Insatisfacción Leve	15 a 19 pts	3.0 a 3.8	Frustraciones menores en áreas clave; necesidad de ajustes vitales.
Insatisfacción Severa	5 a 14 pts	1.0 a 2.8	Disfunción subjetiva grave; desesperanza, duelo patológico o depresión mayor.

PUNTO DE CORTE DE ALERTA CLÍNICA (SWLS < 20 PUNTOS):

Puntuaciones por debajo de **20 puntos** indican un balance neto negativo con respecto a la propia existencia. En contextos clínicos, una puntuación < 15 constituye un potente indicador de riesgo psicopatológico (distimia, depresión, ideación suicida) que demanda exploración clínica integral.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE MONITORIZACIÓN DEL BIENESTAR EN PSICOTERAPIA COGNITIVA Y ACT

PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO CON SWLS EN TERAPIA BASADA EN PROCESOS:

- **Paso 1 (Línea Base en Consulta):** Administrar en la entrevista inicial junto a inventarios sintomáticos (BDI-II, GAD-7).
- **Paso 2 (Evaluación de Coherencia Vital en Fase Intermedia):** - *Si los síntomas de ansiedad remiten pero SWLS permanece* < 18 : Existe disonancia existencial. Indicar clarificación de valores (ACT), revisión de metas y redefinición del propósito vital.
- **Paso 3 (Análisis Ítem por Ítem):** El ítem 5 ("no cambiaría casi nada") es el más exigente; su normalización (≥ 5) marca consolidación de la aceptación psicológica.
- **Paso 4 (Criterio de Alta Terapéutica y Florecimiento):** Mantener SWLS ≥ 26 puntos durante 6 meses como criterio de bienestar resiliente y prevención de recaídas.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: REORIENTACIÓN VITAL EN CRISIS DE LA MITAD DE LA VIDA

Identificación: Varón de 48 años, director financiero, que acude a consulta por sensación de vacío existencial, anhedonia y crisis conyugal incipiente tras 20 años de alta competitividad corporativa: "He conseguido todo lo que se suponía que debía tener, pero siento que mi vida ha sido un fraude".

Evaluación Inicial SWLS: • **Puntuación Total SWLS = 11 / 35 puntos (Insatisfacción Severa con la Vida, Percentil 10).** • **Desglose de Ítems:** Ítem 1 (Vida ideal) = 2; Ítem 2 (Condiciones excelentes) = 3; Ítem 3 (Satisfecho) = 2; Ítem 4 (Cosas importantes) = 3; Ítem 5 (No cambiaría nada) = 1.

Intervención Psicológica: Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT): defusión de mandatos de éxito económico, clarificación de valores orientados a la conexión afectiva familiar y práctica de mindfulness. Se programó reducción de jornada laboral y reanudación de actividades artísticas.

Reevaluación a los 6 Meses: La puntuación SWLS ascendió a **28 / 35 puntos (Alta Satisfacción con la Vida, Percentil 75)**. El paciente restableció la complicidad con sus hijos, reorganizó su tiempo de ocio y verbalizó: "Por primera vez en 20 años siento que vivo mi propia vida".

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

ALERTA DE RIESGO SUICIDA:

Una puntuación extrema en SWLS (≤ 8) asociada a desesperanza profunda en ancianos o enfermos crónicos demanda cribado urgente de ideación autolítica activa.

DESEABILIDAD SOCIAL:

Puntuaciones perfectas (35/35) en procesos periciales o custodias deben interpretarse con cautela ante posible disimulación defensiva o negación maníaca.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction With Life Scale. *Journal of Personality Assessment*, 49(1), 71-75.
2. Pavot, W., & Diener, E. (1993). Review of the Satisfaction With Life Scale. *Psychological Assessment*, 5(2), 164-172.
3. Atienza, F. L., Pons, D., Balaguer, I., & García-Merita, M. L. (2000). Propiedades psicométricas de la Escala de Satisfacción con la Vida en adolescentes. *Psicothema*, 12(2), 314-319.
4. Vázquez, C., Duque, A., & Hervás, G. (2013). Satisfaction with Life Scale in a representative sample of Spanish adults: Validation and normative data. *The Spanish Journal of Psychology*, 16, E82.